

S° Mononucleósicos

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2019
Pediatrics 2010

Etiología

- E. Barr
- CMV
- HIV
- Toxoplasma
- Herpes virus 6

E. Barr (Mononucleosis infecciosa)

Clínica

- Fiebre alta
- Faringoamigdalitis (edema, exudado, petequias faríngeo)
- Adenopatías
- Hepato/esplenomegalia
- Rash cutáneo (100% si recibe ampicilina o amoxicilina)

Trasmisión

Secreciones salivales

Incubación

30-60 días

Fisiopatología

Replicación viral en células epiteliales faríngeas, activación de linfocitos B, con respuesta humoral y celular.

El trastorno linfoproliferativo es autolimitado y benigno

Laboratorio

- Leucocitosis leve, neutropenia relativa, linfomonocitosis (30-90 % de linfocitos atípicos activados, diferentes a los linfoblastos de la LLA)
- Plaquetopenia leve – moderada
- Elevación de transaminasas (transaminitis por 2- 3 semanas)
- Serología
 - Mayor de 4 años: Paul Bunnell
 - Menor de 4 años: serología para VEB
 - IgG Cápside (IgG VCA)
 - IgM Cápside (IgM – VCA)
 - IgG Precoz (IgG – EA)
 - IgG Nucleares (IgG – EBNA): positivo 2 meses, indica convalecencia
 - Pueden dar positivo el FR y ANAS

Diagnóstico diferencial

- S° mononucleósico con serología negativa: probablemente CMV
- Amigdalitis estreptocócica (sin esplenomegalia)
- Infección por HIV, toxoplasmosis, Hep A, HV6
- S° de fatiga crónica

Complicaciones

- Anemia hemolítica autoinmune (Ac. Criooaglutinantes)
- Plaquetopenia severa
- Anemia aplásica
- Infecciones oportunistas por neutropenia
- Rotura esplénica (puede producirse hasta 3 semanas posteriores tras ejercicio, hay dolor abdominal agudo e intenso con neutropenia)
- Meningoencefalitis
- S° de G. Barre, Mieliti transversa
- S° de Reye
- Parálisis facial periférica, neuritis óptica
- Pericarditis, miocarditis
- Hepatitis

Tratamiento

- Sintomatológico
- Paracetamol, ibuprofeno
- ATB si hay estreptococos asociados
- No indicar corticoides ni aciclovir
- Prevenir contagio en inmunodeprimidos

Citomegalovirus

Pertenece a la familia de Herpes

Trasmisión

- Contacto con secreciones (orina, saliva, semen, leche materna, secreciones de cérvix)
- Congénita

Clínica

Inmunocompetentes

- Asintomática
- S° mononucleósico (similar a mononucleosis infecciosa con menos fiebre y adenopatías autolimitadas)

Inmunodeprimidos

- Colitis
- Hepatitis
- Neumonía
- Úlceras digestivas
- Retinitis

Serología

Primoinfección: Ac IgM (hasta 1 mes), IgG (años)

Reinfección: IgG

Tratamiento

- Sintomatológico
- Ganciclovir en inmunocomprometidos
- Vanganciclovir: en retinitis

Herpes virus 6

Exantema súbito

Elevación brusca de la temperatura (puede llegar a 40°) de 2- 4 días, seguido de un descenso rápido que coincide con la aparición de un exantema maculopapular que persiste 1-2 días.

Aparece entre los 6 meses y 3 años.

Tratamiento

- Sintomatológico
- No es necesario antihistamínicos, no cambia el curso de la evolución y no es pruriginoso.

Toxoplasmosis

Etiología: T. Gondii

Infecta humanos y animales (gato, ternera, cerdo)

Trasmisión

- Oral: ingestión de quistes en carne de cerdo, cordero y ternera o vegetales contaminados.
Las enzimas digestivas destruyen el quiste liberando los toquizoitos que se diseminan vía hematógica o linfática y llegan al SNC y músculo cardíaco.
- Transplacentaria

Clínica (toxoplasmosis de transmisión oral)

Inmunocompetentes

- Solo hay síntomas en 10-20 % de los infectados
- Se autolimita en 1-12 meses
- Adenopatías principalmente cervicales y supraclaviculares de 1-3 cm de diámetro, indoloras, no supurante.
- S° febril
- Rash cutáneo maculopapular (respeta palmas y plantas)
- Excepcionalmente:
 - Encefalitis
 - Hepatitis
 - Neumonía
 - Miocarditis
 - Linfocitosis leve
 - Corioretinitis:
En RN puede ser bilateral, en adultos es unilateral
Visión borrosa
Dolor ocular
Fotofobia
Realizar fondo de ojo

Inmunodeprimidos

En HIV puede provocar encefalitis, corioretinitis e infección diseminada.

Laboratorio

- Linfocitosis leve, VSG, GOT y GPT elevadas
- Ac IgM o IgG
- Parasitológico directo
- PCR

Tratamiento

Inmunocompetentes: sólo tratamiento en cuadros severos

Corioretinitis: tratamiento por un mes con corticoides en caso de lesiones cercanas a mácula o N. óptico.

Fármacos:

- Sulfadiazina + pirimetamina
- Clindamicina + pirimetamina
- Clotrimoxazol en encefalitis